Клинические рекомендации

Травма носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S00.3** — Поверхностная травма носа **S01.2** — Открытая рана носа **S02.2** — Перелом костей носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/815_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 3

2. Клиника и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Механизм травмы 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

2.5 Жалобы и анамнез 5

3. Диагностика 5

3.1 Осмотр 5

3.2 Анализы 5

3.3 Лучевая диагностика 5

3.4 Консультации 6

4. Лечение 6

4.1 Обезболивание 6

4.2 Анальгетики у взрослых 6

4.3 Анальгетики у детей 7

4.4 Профилактика столбняка и антибиотики 8

4.5 Отёк, кровотечение, уход за носом 8

4.6 Хирургическое лечение 9

4.7 Анестезия, тампонада, повязка 10

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 11

5.1 Госпитализация 11

6. Источник и актуальность 11

6.1 Неточности в самом тексте КР 12

1. Главное

- Перелом костей носа ищут на рентгенограмме костей лицевого скелета в боковой проекции (взрослым и детям с 3 лет), но её чувствительность не выше 70%, поэтому нормальный снимок перелома не исключает.
- Гематому или абсцесс перегородки носа вскрывают и дренируют, затем ставят переднюю тампонаду и делают ежедневные перевязки, пока не прекратится отделяемое.
- Если травма привела к деформации носа, кости репонируют и фиксируют; раннее вмешательство делают в первые 7 суток, а при тяжёлом состоянии или выраженном отёке его можно отложить до 15 суток.
- При изолированном переломе, даже открытом, системные антибиотики рутинно не назначают; их назначают при загрязнённых и гнойных ранах, выраженном отёчно-токсическом синдроме, осложнённой гематоме или абсцессе перегородки, сочетанной и комбинированной травме и тяжёлой сопутствующей патологии.
- Если повреждены кожа или слизистая и рана загрязнена землёй, проводят экстренную профилактику столбняка — как можно раньше, но не позже 20-го дня после травмы.
- Госпитализируют при тяжёлом состоянии, кровотечении, выраженном отёке или боли, деформации носа со смещением перегородки, осложнениях травмы, тяжёлой сопутствующей патологии, приёме антикоагулянтов или антиагрегантов, а также когда нужна закрытая репозиция.

2. Клиника и классификация

2.1 Определения

Травма носа — повреждение носа прямым или опосредованным действием травмирующего фактора снаружи или изнутри, при котором нарушается целость тканей и структур наружного носа и полости носа и страдают функции носа.

Поверхностной называют травму наружного носа, при которой не повреждены кожа, кости носа и слизистая полости носа и нет неврологических симптомов.

Ушиб носа — закрытое повреждение тупым предметом без видимого нарушения кожи и слизистых, с разрывом мелких сосудов и кровоизлиянием. При кровоподтёке кровь пропитывает мягкие ткани наружного носа, тогда как гематома — это скопление крови в ограниченной полости. Ссадина — повреждение поверхностного слоя кожи, при котором видно место размозжения кожных сосудов.

Перелом костей носа (ПКН) — частичное или полное нарушение целости носовых костей, лобных отростков верхней челюсти, перегородки носа или носовой ости. Перелом закрытый, если кожа носа цела, и открытый, если отломки сообщаются с внешней средой через рану.

Рана носа — повреждение кожи наружного носа на всю глубину, часто с обнажением хрящей и костей и более глубоких структур полости носа, иногда с отрывом крыла или кончика носа.

2.2 Механизм травмы

При ударе во фронтальной плоскости ломаются носовые кости и западает спинка носа. Удар сбоку может разъединить носовую кость и лобный отросток верхней челюсти и сформировать сколиоз наружного носа, но чаще линия перелома проходит выше шва между ними. Обычно одновременно ломается и перегородка носа, чаще всего её хрящевой отдел.

У детей младшего возраста кости наружного носа эластичны, поэтому переломы бывают редко, а гематома и абсцесс перегородки носа — чаще.

При переломе нередко рвётся и отслаивается надхрящница или надкостница перегородки, и между хрящом и надхрящницей скапливается кровь — так образуется гематома перегородки носа. Если она инфицируется, развивается абсцесс, четырёхугольный хрящ расплавляется, и нос деформируется, а его функции нарушаются.

Травма носа бывает изолированной или сочетается с повреждением околоносовых пазух, глаза, скуловой области, нижней челюсти, полости рта, ушной раковины, сотрясением или ушибом головного мозга.

2.3 Классификация

Общепринятой классификации переломов нет. По классификации Ю. Н. Волкова (1958) переломы бывают открытыми и закрытыми, без деформации и с деформацией наружного носа.

По классификации С. Б. Бесшапочного (1984) переломы делят на переломы без деформации и с деформацией наружного носа; последние бывают одно- и двусторонними, с боковым смещением отломков, со смещением кзади или с сочетанием обоих.

По классификации А. С. Лопатина (2019) переломы бывают изолированными и сочетанными, открытыми и закрытыми; переломы со смещением делят по направлению удара — латеральному, фронтальному, фронтолатеральному и базальному.

По распространённости переломы бывают изолированными (с деформацией наружного носа или без неё), комбинированными — с травмой кожи лица, внутриносовых структур или околоносовых пазух — и сочетанными — с челюстно-лицевой или черепно-мозговой травмой, травмой конечностей, туловища и внутренних органов.

Перелом со смещением проходит три стадии. Острая стадия — первые 14 дней: кости репонируют по стандартной методике. Застарелый перелом — от двух недель до двух месяцев: репозиция возможна только вместе с операцией на перегородке носа. Стойкая деформация — больше двух месяцев: отломки можно сопоставить только после остеотомии.

2.4 Клиническая картина

Поверхностная травма проявляется слабо: в месте удара есть боль, небольшая припухлость и умеренное покраснение кожи без её повреждения.

При ушибе пирамида носа увеличена и её контуры сглажены из-за отёка; при кровоподтёке и ссадине меняются цвет и целость кожи; при переломе пирамида смещена вбок или вдавлена; при гематоме перегородка утолщена, а носовые ходы сужены. Бывают носовое кровотечение, боль и болезненность при пальпации, нарушение дыхания и обоняния. При сочетанной травме добавляются отёки, кровоподтёки, гематомы и раны в других зонах, нарушения зрения и сознания.

Симптомы перелома — отёк, боль, деформация наружного носа, крепитация и подвижность отломков, носовое кровотечение и затруднённое носовое дыхание.

У детей с переломом деформацию носа удаётся увидеть только в 57,5% случаев из-за выраженного отёка. Кроме того, у 7,4% детей деформация была и до травмы.

При переломе нередко повреждены кожа носа и слизистая полости носа, бывают эмфизема мягких тканей носа и лица и экхимозы. Носовое кровотечение частое, но при неосложнённом изолированном переломе оно редко бывает сильным и повторяющимся.

Перелом часто сопровождается кровоизлиянием в веки и мягкие ткани орбиты — «симптомом очков», однако этот же симптом бывает при переломе переднего основания черепа и травме кавернозного синуса.

Крепитация и подвижность отломков встречаются меньше чем в половине случаев, поэтому их отсутствие перелом не исключает. Боль в области носа тоже не специфична: она бывает при ушибах и воспалительных болезнях носа.

2.5 Жалобы и анамнез

Выясняют обстоятельства и механизм травмы, направление удара, была ли потеря сознания. Уточняют, были ли раньше травмы носа с деформацией и операции на носу. При комбинированной травме с повреждением кожи узнают о прививках от столбняка. При общем осмотре оценивают артериальное давление, пульс и частоту дыхания.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по факту травмы со слов пострадавшего или очевидцев; по жалобам на боль, изменение формы носа, затруднённое дыхание, кровотечение и нарушение обоняния; по осмотру — повреждениям кожи, деформации, крепитации и подвижности отломков, кровотечению. Перелом подтверждают рентгенографией костей лицевого скелета, а при противопоказаниях — УЗИ костей носа. При сочетанной травме повреждения пазух, орбиты, скуловой кости, верхней челюсти и черепа ищут на рентгенограммах черепа и КТ.

3.1 Осмотр

Каждого пациента с травмой носа осматривает оториноларинголог, чтобы определить характер и выраженность повреждений.

Всем пациентам пальпируют челюстно-лицевую область, чтобы уточнить характер травмы и выраженность повреждений.

При осмотре фиксируют отёк, гематомы, ссадины и раны, оценивают, есть ли деформация и насколько она выражена. При пальпации ищут крепитацию отломков, подкожную эмфизему и гематому, оценивают область носового клапана, подвижность крыльев носа и подвижной части перегородки. Для врачебной и судебно-медицинской экспертизы важно сфотографировать повреждения.

3.2 Анализы

Если травма сопровождается кровотечением, исследуют коагулограмму: она нужна, чтобы оценить гемостаз и кровопотерю и подготовиться к операции, если она потребуется.

3.3 Лучевая диагностика

Взрослым и детям с 3 лет делают рентгенографию костей лицевого скелета, чтобы выявить костные повреждения.

Снимок в боковой проекции важен и для диагноза, и юридически: в 70,2% случаев он показывает перелом и характер смещения отломков. Обычно ломаются обе носовые кости, но бывают одиночные и множественные переломы, поэтому, чтобы уточнить сторону перелома, боковые снимки делают при положении головы на левой и на правой стороне.
Чувствительность рентгенографии при переломе костей носа не выше 70%, а смещение во фронтальной плоскости на боковом снимке не видно. У детей до 3 лет снимок малоинформативен из-за слабой оссификации и преобладания хрящей. Поэтому отрицательный результат перелома не исключает.

Если подозревают смещение отломков в переднезаднем направлении, а на боковом снимке изменений нет, взрослым и детям с 3 лет делают рентгенографию околоносовых пазух.

Смещение отломков снаружи внутрь, невидимое на боковых снимках, выявляют на рентгенограмме околоносовых пазух в носоподбородочной проекции.

При комбинированной и сочетанной травме черепа делают КТ лицевого отдела черепа или челюстно-лицевой области и (или) КТ головного мозга.

КТ нужна при комбинированных и сочетанных переломах, признаках черепно-мозговой травмы (ЧМТ), неинформативной рентгенографии при клинических признаках перелома, планировании расширенной операции, подозрении на назальную ликворею, тяжёлом состоянии, продолжающемся или повторяющемся носовом кровотечении. Зону исследования выбирают по сопутствующей патологии.

Чувствительность КТ при переломе приближается к 100%. Исследование проводят в режиме спирального сканирования с толщиной среза 3 мм; оно показывает положение отломков, перегородку носа, повреждения пазух, орбиты, мозгового черепа, мягких тканей и мозга. Перед операцией рекомендуют 3D-реконструкцию.

Если лучевые методы противопоказаны, делают УЗИ костей носа.

УЗИ просто, неинвазивно, не облучает пациента и его можно повторять, чтобы контролировать репозицию и сращение отломков. Исследуют в четырёх проекциях: передней продольной, передней поперечной, правой и левой боковой.

3.4 Консультации

При подозрении на повреждение органа зрения пациента консультирует офтальмолог.

Всех пациентов с травмой носа консультирует невролог, чтобы вовремя выявить сопутствующую патологию.

При массивном кровотечении и сочетанной травме регистрируют ЭКГ, чтобы оценить сердечно-сосудистую систему и спланировать лечение.

4. Лечение

Консервативное лечение уменьшает боль и отёк, предупреждает бактериальное воспаление в зоне повреждения, ускоряет заживление и восстановление функций носа.

4.1 Обезболивание

Всем пациентам при отсутствии противопоказаний назначают анальгетики.

Сильная боль и стресс от травмы способствуют развитию или утяжелению травматического шока.

Применяют анальгетики-антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) по отдельности или вместе; у взрослых и детей, в том числе после операции, рекомендуют сочетать НПВП с парацетамолом, а также метамизол натрия. У детей из НПВП можно ибупрофен с 3 месяцев и кетопрофен с 15 лет, а кетопрофен в гранулах для приготовления раствора — с 6 лет. Метамизол натрия детям амбулаторно не назначают, а в стационаре используют, только если нет других разрешённых детям анальгетиков, из-за риска серьёзных нежелательных явлений.

4.2 Анальгетики у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	1 г внутривенно, инфузия 15 минут	4 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 мг внутримышечно (в таблице КР — «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 суток
Кеторолак	30 мг внутривенно, внутримышечно	6 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	200 мг	не более 2 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Лорноксикам	8 мг внутривенно, внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно, внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

> В таблице 2 разовая доза диклофенака записана как «75 мл в/м» — единица измерения указана неверно; по смыслу таблицы и суточному максимуму 150 мг речь идёт о 75 мг.

4.3 Анальгетики у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия 15 минут: меньше 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; больше 50 кг — 1000 мг	4 ч	Меньше 10 кг — до 30 мг/кг; 10–50 кг — до 60 мг/кг, но не более 2 г (для 33–50 кг в той же ячейке — не более 3 г); больше 50 кг — 4 г	5–7 суток
Парацетамол внутрь	10–15 мг/кг	6 ч	не более 60 мг/кг	3–5 суток
Парацетамол ректально	3–12 месяцев — 50–100 мг; 1–3 года — 100–150 мг; 3–5 лет — 150–200 мг; 5–10 лет — 250–350 мг; 10–14 лет — 350–500 мг	6 ч	до 60 мг/кг	до 5 суток
Ибупрофен внутрь	3–6 месяцев — 50 мг; 6–12 месяцев — 50 мг; 1–3 года — 100 мг; 4–6 лет — 150 мг; старше 6 лет — 200–400 мг	6–8 ч (в ячейке есть и «8 ч» без пояснения)	3–6 месяцев — 150 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 1–3 года — 300 мг; 4–6 лет — 450 мг; 6–12 лет — 800 мг; 12–17 лет — 1 г	4 суток
Ибупрофен ректально	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	3–9 месяцев — 8 ч; 9–24 месяца — 6 ч	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	не более 3 суток
Метамизол натрия	С 15 лет — 500–1000 мг внутривенно, внутримышечно; 2–14 лет — 50–100 мг/кг внутримышечно, внутривенно; от 3 месяцев до года — 50–100 мг на 10 кг внутримышечно	8–12 ч	с 15 лет — 2 г	1–5 суток; детям младше 15 лет — 3 суток

> В таблице 3 есть несогласованности. Для внутривенного парацетамола диапазоны веса пересекаются: для 33–50 кг указан суточный максимум 3 г, а для 10–50 кг — 2 г. Для метамизола натрия детям 2–14 лет указано 50–100 мг/кг, а детям до года — 50–100 мг на 10 кг, то есть в 10 раз меньше на килограмм. Дозы стоит сверить с инструкцией.

4.4 Профилактика столбняка и антибиотики

Если повреждены кожа или слизистая и травма получена при ударе о землю или в рану попала почва, вводят вакцину для профилактики столбняка.

Экстренную профилактику проводят как можно раньше, вплоть до 20-го дня после травмы, учитывая инкубационный период столбняка. Она включает первичную хирургическую обработку раны и одновременное введение столбнячного анатоксина, противостолбнячного иммуноглобулина человека или столбнячного антитоксина по инструкции.

При изолированном переломе костей носа, в том числе открытом, системные антибиотики до и после операции рутинно не назначают.

Профилактические антибиотики не снижают риск инфекционных осложнений после репозиции костей носа ни у взрослых, ни у детей.

Системные антибиотики назначают при загрязнённых и гнойных ранах кожи и слизистой, выраженном отёчно-токсическом синдроме, осложнённой гематоме или абсцессе перегородки носа, сочетанной и комбинированной травме и тяжёлой сопутствующей патологии.

При явном бактериальном воспалении или высоком риске его развития назначают препараты широкого спектра — бета-лактамы: цефазолин, цефтриаксон, ампициллин с сульбактамом, амоксициллин с клавулановой кислотой. При аллергии на бета-лактамы применяют клиндамицин.

Ампициллин с сульбактамом и амоксициллин с клавулановой кислотой шире, чем цефазолин, действуют на грамотрицательные и анаэробные бактерии.

Препарат	Доза
Ампициллин и сульбактам	Внутримышечно и внутривенно. Взрослым по тяжести инфекции 3–12 г в сутки в 3 введения, детям — 150 мг/кг в сутки в 3 введения (новорождённым — в 2), 5–14 дней.
Амоксициллин и клавулановая кислота	Внутривенно. Взрослым и детям старше 12 лет — по 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки, детям младше 12 лет — 25 мг/кг 3 раза в сутки, 5–14 дней.

4.5 Отёк, кровотечение, уход за носом

При выраженном отёке взрослым и детям старше 15 лет назначают ангиопротекторы, чтобы раньше можно было репонировать отломки и предупредить осложнения.

На спинку носа местно наносят троксерутин (взрослым и детям старше 15 лет) или гель гепарина натрия на неповреждённую кожу 2 раза в день, пока отёк не пройдёт.

При обильном кровотечении, а также для профилактики кровотечения во время и после операции назначают гемостатические средства.

Кровотечение бывает из полости носа и из повреждённых мягких тканей при открытых ранах. Механическую остановку кровотечения обычно дополняют гемостатиками: этамзилатом, транексамовой или аминокапроновой кислотой.

Препарат	Взрослые	Дети
Этамзилат	Для остановки кровотечения — 250–500 мг внутривенно или внутримышечно, затем по 250 мг каждые 4–6 часов. При репозиции — 250–500 мг за час до операции, при необходимости 250–500 мг во время операции и 500–750 мг равномерно в течение суток после неё.	10–15 мг/кг в сутки в 3–4 приёма, 5–10 дней. Во время операции — 8–10 мг/кг внутривенно, затем 10–15 мг/кг в течение суток.
Транексамовая кислота	Внутривенно капельно или медленно струйно со скоростью 1 мл/мин (50 мг/мин), 10–15 мг/кг каждые 6–8 часов до остановки кровотечения.	Старше 1 года — 20 мг/кг в сутки до остановки кровотечения.
Аминокапроновая кислота	Внутривенно капельно: 4–5 г за первый час, при продолжающемся кровотечении — по 1 г в час не дольше 8 часов; при необходимости инфузии повторяют каждые 4 часа; не более 30 г в сутки. Курс 3–14 дней.	100 мг/кг за первый час, затем 33 мг/кг в час; не более 18 г/м² в сутки (до года — 3 г, 2–6 лет — 3–6 г, 7–10 лет — 6–9 г, старше 10 лет — как взрослым). При острой кровопотере: до года — 6 г, 2–4 года — 6–9 г, 5–8 лет — 9–12 г, 9–10 лет — 18 г.

> Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере больше указанных рядом максимальных суточных доз: например, до года — 6 г при максимуме 3 г, в 9–10 лет — 18 г при максимуме 6–9 г.

Всем пациентам для облегчения носового дыхания назначают деконгестанты и другие назальные препараты.

Сосудосуживающие спреи и капли уменьшают реактивный отёк слизистой после травмы и облегчают дыхание после операции.

Препарат	Доза
Фенилэфрин 0,125%	Интраназально: до года — 1 капля, 1–6 лет — 1–2 капли, старше 6 лет — 3–4 капли до 3 раз в сутки, до 7 дней.
Оксиметазолин	До года — 0,01%, 1–6 лет — 0,025%, старше 6 лет — 0,05%; по 1–2 капли интраназально 2–3 раза в сутки, до 5 дней.
Ксилометазолин	2–6 лет — 0,05%, старше 6 лет — 0,1%; спрей по 1 дозе 2–3 раза в сутки, до 5 дней.

При повреждении кожи или слизистой с признаками инфицирования раны или высоким риском инфицирования назначают местные антисептики.

Используют бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (спрей — не детям до 3 лет), повидон-йод и хлоргексидин. Как часто обрабатывать рану, зависит от воспаления и экссудата; обрабатывают до разрешения инфекции или начала заживления.

Всем пациентам промывают нос, чтобы ускорить заживление слизистой.

Уход за полостью носа после травмы и операции ускоряет заживление и предупреждает осложнения, например синехии. Используют стерильные изотонические растворы морской воды 2–3 раза в день, пока слизистая не эпителизируется и не стихнет воспаление.

4.6 Хирургическое лечение

Неотложно при травме носа останавливают кровотечение и проводят первичную хирургическую обработку открытых ран. При переломе операция нужна, чтобы восстановить форму наружного носа, устранить смещение внутриносовых структур и вернуть дыхание.

При открытых ранах и открытых переломах рану хирургически обрабатывают, иссекают инфицированные ткани и накладывают косметический шов.

Перед швом рану тщательно осматривают, удаляют инородные тела и зондируют раневой канал.

Если гемостатики и тампонада не помогают, кровотечение останавливают хирургически.

Метод выбирают по источнику. При кровотечении из передних отделов отслаивают участок мукоперихондрия с последующей тампонадой, выскабливают расширенный сосуд, применяют криокоагуляцию или электрокаустику. При обильном кровотечении перевязывают наружную сонную артерию, эндоскопически клипируют сосуды или выполняют эндоваскулярную эмболизацию. При кровотечении из решётчатых артерий делают этмоидотомию наружным, внутренним или эндоназальным доступом.

Гематому или абсцесс перегородки носа вскрывают и дренируют.

После вскрытия ставят переднюю тампонаду и делают ежедневные перевязки, пока не прекратится отделяемое.

Если травма привела к деформации наружного носа, кости репонируют и фиксируют отломки, чтобы восстановить форму носа и дыхание.

Операция бывает ранней — в первые 7 суток после травмы, отложенной — на 8–15-е сутки, и плановой — через 6 месяцев и позже.

Рано оперируют при минимальном или умеренном отёке, а также при комбинированной травме с повреждением внутриносовых структур или пазух и при гематоме перегородки. Ранняя операция помогает избежать септических осложнений и синехий.

При тяжёлом состоянии, выраженном отёке, комбинированных переломах костей и перегородки носа и ранениях лица операцию можно отложить до 15 суток.

> По классификации в разделе 1.5 острая стадия, когда кости репонируют по стандартной методике, длится 14 дней, а после двух недель репозиция возможна только с операцией на перегородке. В разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.

Планово (риносептопластикой) переломы оперируют при сочетанной травме с переломом основания черепа и назальной ликвореей и при тяжёлых функциональных нарушениях.

Кости репонируют наружным (пальцевым), эндоназальным (инструментальным) или экстраназальным (открытым) способом. У детей наружный способ эффективен лишь в 22% случаев, поэтому им лучше репонировать эндоназально элеваторами Манакова или Волкова с последующей передней тампонадой. Открытый способ применяют, когда одновременно оперируют по поводу внутричерепной травмы или травмы лобных пазух и верхней челюсти.

При комбинированных назосептальных переломах в остром периоде одновременно репонируют кости и выполняют септопластику. При сочетанной травме репозицию лучше делать вместе с другими хирургами, если они оперируют под наркозом.

При подозрении на черепно-мозговую травму вправление откладывают до осмотра невролога или нейрохирурга и нужных обследований.

4.7 Анестезия, тампонада, повязка

При операциях по поводу открытых и закрытых переломов и смещения внутриносовых структур проводят анестезию наружного носа и полости носа.

Взрослым при изолированной травме наносят местный анестетик на слизистую полости носа и вводят анальгетики внутримышечно или проводят проводниковую анестезию артикаином. Детям рекомендуют сочетанную анестезию.

При переломах костей наружного носа и внутриносовых структур ставят переднюю тампонаду, чтобы удержать сопоставленные отломки и остановить кровотечение при травме слизистой.

Тампон вводят на стороне деформации и удаляют на 2–3-и сутки после операции; срок зависит от подвижности отломков. Польза длительной тампонады (больше 3–5 дней) после репозиции не доказана.

При переломах, сложных травмах и после операций накладывают пращевидную повязку, чтобы отломки не сместились.

Наружную шину после закрытой репозиции рутинно не применяют, только при тяжёлых оскольчатых переломах.

При выраженных реактивных воспалительных явлениях пациента консультирует физиотерапевт.

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области и магнитотерапия уменьшают воспаление и отёк и ускоряют заживление.

На время лечения пациенту советуют ограничить физическую активность, избегать действий, которые могут сместить отломки, в том числе во сне, есть полноценную витаминизированную легкоусвояемую пищу и не ходить в горячую ванну, душ, сауну и бассейн.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

После операций по поводу деформации наружного носа или перегородки пациента в течение года наблюдает оториноларинголог; обязательные осмотры — через 1, 3 и 6 месяцев и через год после операции.

Травмы предупреждают общими социальными мерами профилактики травматизма.

Это соблюдение техники безопасности в детских учреждениях, на производстве и в быту, разъяснительная работа с родителями и пропаганда здорового образа жизни.

5.1 Госпитализация

Госпитализируют при тяжёлом состоянии, выраженном отёке, кровотечении, сильной боли; при комбинированных переломах костей и перегородки носа с повреждением пазух и ранениями лица; при травматической деформации носа со смещением перегородки или нарушением дыхания; при тяжёлой сопутствующей патологии; пациентов, принимающих антикоагулянты или антиагреганты; при осложнениях — гематоме и абсцессе перегородки, воспалении пазух и соседних областей; а также если нужна закрытая репозиция.

Выписывают при удовлетворительном состоянии и нормальных клинических показателях, улучшении формы носа и носового дыхания и отсутствии осложнений.

Прогноз благоприятный, если лечение проведено по рекомендациям и пациент выполняет назначения врача.

Пациенту объясняют, что при выраженном отёке лица, деформации носа, повреждении мягких тканей, кровотечении из носа или нарушении дыхания нужна экстренная консультация оториноларинголога: запоздалое лечение может привести к опасным осложнениям.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма носа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 20.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	815_1 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- В разделе 1.4 коды МКБ записаны с лишней точкой: «S.00.3», «S.02.2», «S.02.20», «S.02.21»; на титульном листе — правильно (S00.3, S02.2 и т. д.).
- В таблице 2 разовая доза диклофенака указана как «75 мл в/м» вместо миллиграммов.
- В таблице 3 для внутривенного парацетамола пересекаются весовые диапазоны с разными суточными максимумами (33–50 кг — 3 г, 10–50 кг — 2 г); для метамизола натрия доза у детей 2–14 лет (50–100 мг/кг) в 10 раз больше на килограмм, чем у детей до года (50–100 мг на 10 кг). Для ибупрофена внутрь в графе интервала стоят и «6–8 ч», и «8 ч» без пояснения.
- Для аминокапроновой кислоты у детей дозы при острой кровопотере (до года — 6 г, 9–10 лет — 18 г) превышают указанные рядом максимальные суточные дозы (3 г и 6–9 г).
- Острая стадия перелома в разделе 1.5 — 14 дней, а в разделе 3.2 отложенная операция допускается до 15-х суток.
- Критерии качества требуют рентгенографии или КТ у всех пациентов, тогда как рентгенографию рекомендуют только с 3 лет.
- В рекомендации о коагулограмме написано «система гомеостаза» вместо «гемостаза»; в оглавлении номера страниц разделов 6, 7 и критериев качества не совпадают с текстом.